

Vacunas obligatorias y recomendadas en Chile (2025)

1. Introducción y relevancia clínica

La inmunización sistemática es una de las intervenciones de salud pública **más costo-efectivas y con mayor impacto poblacional**.

Chile cuenta con un **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)** desde 1978, el cual garantiza **vacunas gratuitas y obligatorias** para toda la población, especialmente en la infancia.

Con la evolución epidemiológica y tecnológica, el PNI ha incorporado nuevas vacunas y actualizado esquemas. Además, existen **vacunas recomendadas** (no obligatorias), indicadas para **grupos de riesgo, personal sanitario, viajeros o determinadas condiciones clínicas**.

El médico debe conocer **cuáles vacunas son de administración obligatoria**, cuáles son **recomendadas**, y las **nuevas vacunas en implementación o vigilancia epidemiológica**, pues estos temas son **preguntas frecuentes del EUNACOM** y forman parte de la práctica clínica preventiva habitual.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo inmunológico de las vacunas

Las vacunas actúan simulando una infección natural sin causar enfermedad, lo que permite:

1. Activar el sistema inmune adaptativo (linfocitos B y T).
2. Generar **anticuerpos neutralizantes** y **memoria inmunológica**.
3. Disminuir la transmisión comunitaria mediante **inmunidad de grupo**.

Las **vacunas vivas atenuadas** inducen inmunidad más duradera pero requieren precauciones (ej. BCG, SRP, varicela).

Las **vacunas inactivadas o subunitarias** son seguras en inmunocomprometidos pero requieren refuerzos periódicos.

b. Criterios del PNI para definir obligatoriedad

El MINSAL define una vacuna como **obligatoria** cuando:

- Previene una enfermedad **endémica o epidémica** de importancia nacional.
- Existen **evidencia y factibilidad técnica** para su implementación universal.
- Su aplicación tiene **alta eficacia y seguridad comprobadas**.

Por el contrario, se consideran **recomendadas** aquellas destinadas a:

- Grupos de riesgo (comorbilidades, inmunodepresión, prematuros, adultos mayores).
- Exposición laboral o geográfica especial.
- Prevención individual ante viajes o brotes específicos.

3. Vacunas obligatorias en Chile (PNI 2025)

De acuerdo al **Calendario Nacional MINSAL–DEIS 2025**, las siguientes vacunas son **obligatorias y gratuitas** para toda la población en sus respectivas edades o condiciones:

a. En el recién nacido

- **BCG**: previene tuberculosis miliar y meníngea.
- **Hepatitis B**: protege contra hepatitis viral crónica y cirrosis.

b. En lactantes y preescolares

Edad	Vacuna	Tipo / componentes
2, 4 y 6 meses	Pentavalente (DTPa-HB-Hib)	Difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B, <i>H. influenzae</i> tipo b
2, 4 y 6 meses	Polio (IPV)	Poliomielitis inactivada

2, 4 y 12 meses	Neumocócica conjugada 13V	<i>S. pneumoniae</i>
2 y 4 meses	Rotavirus	Gastroenteritis viral
12 meses	SPR (sarampión, parotiditis, rubéola)	Triple viral viva atenuada
12 meses	Meningocócica ACWY	<i>N. meningitidis</i>
18 meses	DTPa, IPV, Hepatitis A (1ª dosis)	Refuerzo y prevención hepatotrópica
5 años	DTPa, IPV, SPR (2ª dosis)	Refuerzos preescolares

c. En escolares y adolescentes

Edad	Vacuna	Finalidad
10 años	dTpa (refuerzo)	Difteria, tétanos, tos ferina
10 años (niños y niñas)**	VPH (1ª dosis)	Prevención cáncer cervicouterino, orofaríngeo
11 años	VPH (2ª dosis)	Completa esquema

d. En embarazadas y adultos mayores

Grupo	Vacuna	Finalidad
Embarazadas ≥28 semanas	dTpa	Protección pasiva del RN contra tos ferina
Embarazadas (cualquier trimestre)	Influenza	Disminuye complicaciones respiratorias
≥65 años	Influenza anual y neumocócica polisacárida 23V	Previene neumonía, sepsis y muerte

4. Vacunas recomendadas (no obligatorias)

El **MINSAL** y la **Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE)** recomiendan adicionalmente las siguientes vacunas para **grupos de riesgo o prevención individual**, aunque no estén incluidas en el PNI universal.

Vacuna	Indicaciones específicas	Comentarios
Varicela	Niños >12 meses sin historia clínica ni vacunación previa	Se aplica en el sistema privado; evita hospitalizaciones
Meningococo B	Lactantes y adolescentes (brotes, UCIN)	Previene meningitis y sepsis graves
Hepatitis A (2ª dosis)	A los 24 meses o según riesgo	Completa inmunidad prolongada
Influenza anual	Población general	Recomendada incluso fuera de grupo objetivo

COVID-19 (bivalente)	Niños ≥6 meses, personal de salud, crónicos	Mantiene inmunidad comunitaria
Hepatitis B	Personal de salud, hemodiálisis, parejas sexuales múltiples	Esquema de 3 dosis (0-1-6 meses)
Fiebre amarilla	Viajeros a zonas endémicas (Amazonas, África)	Vacuna viva atenuada, una dosis de por vida
Rabia	Exposición laboral o mordeduras de riesgo	3 dosis + refuerzo

□ La vacuna **RSV (virus respiratorio sincicial)** comenzó su implementación en Chile en 2024–2025 para **embarazadas** (protección pasiva al RN), según protocolo MINSAL y AAP.

5. Exámenes complementarios y criterios de aplicación

Generalmente **no se requieren exámenes previos** a la vacunación, salvo:

- Antecedentes de inmunodeficiencia (VIH, quimioterapia).
- Reacciones alérgicas graves previas.
- Uso reciente de inmunoglobulina (que puede interferir con vacunas vivas).

Contraindicaciones absolutas:

- Reacción anafiláctica a dosis previa o componente.
- Inmunodeficiencia severa (vacunas vivas).
- Embarazo (en vacunas vivas).
- Encefalopatía postvacunal previa (en DTPa).

Contraindicaciones relativas o temporales:

- Fiebre alta >38,5 °C.

- Enfermedad aguda grave.
 - Uso de corticoides a dosis inmunosupresora.
-

6. Tratamiento y manejo postvacunal

a. Reacciones leves

- Fiebre baja, dolor local, eritema → **paracetamol**.
- No contraindica refuerzos.
- Compresas frías locales útiles.

b. Reacciones graves

- Anafilaxia → **adrenalina IM 0,01 mg/kg**.
- Notificación inmediata al **DEIS (PNI-MINSAL)**.

c. Repetición o refuerzo

- Si se interrumpe esquema → **no reiniciar**, continuar desde la última dosis válida.
-

7. Complicaciones y pronóstico

Las vacunas son seguras y con excelente perfil beneficio/riesgo.

Las complicaciones graves son rarísimas (1/100.000 o menos).

Complicaciones potenciales:

- **BCG**: adenitis regional o absceso (1/10.000).
- **SRP**: fiebre o exantema leve (5 %).
- **DTPa**: llanto persistente, somnolencia.

- **Rotavirus:** riesgo de invaginación <1/100.000 dosis.

Pronóstico:

La inmunización sostenida ha permitido eliminar en Chile:

- **Poliomielitis (1991)**
- **Sarampión autóctono (1993)**
- **Tétanos neonatal (1998)**

y mantener controladas la difteria, tos ferina y hepatitis B.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. Todas las **vacunas del PNI son obligatorias y gratuitas** (Decreto MINSAL).
2. Las **vacunas vivas atenuadas** se contraindican en **inmunodeprimidos y embarazadas**.
3. **Rotavirus solo se aplica antes de los 8 meses**.
4. **Influenza y COVID-19 son recomendadas anualmente**, incluso en población general.
5. **Embarazadas deben recibir dTpa desde las 28 semanas**.
6. **Varicela y meningococo B** son vacunas **recomendadas**, no del PNI.
7. **RSV materna** es la incorporación más reciente al programa nacional (protección pasiva neonatal).

☐ **Errores frecuentes:**

- Administrar vacunas vivas en inmunodeprimidos.
- Confundir vacunas del PNI con las recomendadas (ej. varicela).
- Omitir segunda dosis de VPH.

- No aplicar refuerzo de hepatitis A a los 24 meses.
 - No registrar vacunas aplicadas fuera del sistema público.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **PNI chileno** garantiza vacunas **obligatorias, gratuitas y seguras** para todos los niños y embarazadas.
2. Las **vacunas recomendadas** complementan la protección en grupos de riesgo (varicela, meningococo B, COVID-19, RSV).
3. Las **vacunas vivas atenuadas** (BCG, SRP, varicela) se evitan en inmunodeficiencias y embarazo.
4. **Rotavirus antes de los 8 meses** y **VPH a los 10 y 11 años** son puntos frecuentes en EUNACOM.
5. La **vacunación materna con dTpa y RSV** protege al RN desde el nacimiento.
6. No se reinician esquemas interrumpidos: **se continúan**.
7. El cumplimiento del calendario permite mantener **cobertura ≥ 95 % y control epidemiológico nacional**.